

An illustration of a male student with dark hair, wearing a blue long-sleeved shirt and purple pants, standing next to a female medical professional. She is wearing a green lab coat, a green cap with a white cross, and holding a purple clipboard. They are both smiling. The background is a light beige color with a decorative wavy border at the top in shades of blue and teal.

GUIA PRÁTICO PARA O OSCE



Mentoria Med
por **Thamyres Maria e Aldo Virgínio**



Sumário

Anamnese geral	3
Sistema Cardiovascular	4
Dor torácica	4
Angina.....	5
Infarto agudo do miocárdio	6
Hipertensão arterial sistêmica	6
Pericardite	7
Insuficiência venosa crônica	8
Endocardite.....	8
Doença arterial obstrutiva periférica	9
Insuficiência cardíaca	10
Febre reumática.....	11
Valvulopatias	11
Sistema respiratório	12
Asma	12
DPOC.....	14
Tromboembolismo pulmonar	15
Pneumotórax	16
Derrame pleural.....	16
Pneumonia.....	18
Tuberculose	19
Arboviroses	20
Protocolo SPIKES.....	21
Protocolo SPIKES JÚNIOR.....	24





Anamnese

Primeiro de tudo, o médico deve se apresentar, exemplo:

Apresentação do médico: "Olá, eu me chamo André, sou o médico do "serviço de saúde" (USF/UPA/POSTINHO/HOSPITAL/MATERNIDADE)

Após isso, você precisa pedir a identificação do paciente e outras informações

Identificação do paciente: Nome, idade, peso, altura, profissão, sexo, raça, religião

Feito isso, você vai precisar "interrogar" o paciente, priorizando sua QUEIXA PRINCIPAL

Exemplo: O que trouxe você aqui? O que te aflige?

Priorizando a queixa principal, você irá direcionar o paciente com perguntas chaves, pra que não fuja o máximo da consulta

Fez tudo isso? Show de bola, agora vamos para os sinais vitais

- Pressão arterial (120x80mmHg)
- Frequência cardíaca (50 a 100)
- Frequência respiratória (16 a 20)
- Oximetria (>95%)
- Temperatura (36,5°)
- Pulso (amplitude, duração e simetria)

Pegou os sinais vitais do paciente? Bora pra próxima etapa!

Anamnese em si!

O que vai te guiar pra anamnese é a Queixa principal do paciente! Você sabendo disso, já é meio caminho andado

Agora você vai perguntar se o paciente tem:

- DOENÇAS PRÉVIAS: HAS, DM, IC, IAM prévio;
- OS HÁBITOS DE VIDA: como é a alimentação, se faz atividade física, tabagismo, etilismo;
- HISTÓRICO FAMILIAR
- USO DE MEDICAÇÃO

Se o paciente referir dispneia:

- Piora com a respiração? — se respira dói
- Piora a noite ou de dia?
- Piora aos esforços? — se escova os dentes, se sobe uma escada, se faz atividade física;
- Melhora com alguma posição? Quando se levanta, se deita, deita de lado, se senta
- Há expectoração? — presença de tosse, se a tosse tem expectoração, o aspecto desse muco (amarelado, branco, esverdeado)
- Há febre? Ela acompanha sudorese, qual o horário mais comum dessa febre?





FEZ TUDO ISSO? Então vamos para o exame físico.

PELO AMOR DE DEUS, LAVA AS MÃO ANTES DE INICIAR O EXAME FÍSICO!!!

Cardíaco

Inspeção: – Estase jugular, Cianose, Leito ungueal e polpas digitais + baqueteamento digital, Xantelasmas (máculo papulares), Prega lobular diagonal - Relação com doença coronariana e aterosclerose, Tipo de tórax, pectus excavatum, Pectus carinatum → DPOC, sínd de Marfan

Palpação-Ictus cordis (desviado?), Pulso- carotídeo, braquial, radial, femoral, pedioso, tibial posterior

Percussão- geralmente não tem muito

Ausulta- Focos cardíacos (sopro/abafamento/atrito?)

Pulmonar

Inspeção: Tórax (Barril) / Ritmo respiratório, dispneia, trepopneia (dispneia que aparece em decúbito lateral), ortopneia (dispneia que impede o paciente de ficar deitado), hemoptise, escarro, tosse, baqueteamento digital

Palpação: Frêmito Toracovocal (aumentado ou diminuído?) / Expansibilidade (aumentada ou diminuída?)

Percussão: Maciço ou timpânico?

Ausulta: Murmúrio vesicular presentes ou ausentes, ruídos adventícios (estertores/sibilos/atrito/crepitação)

Sistema cardiovascular

Dor torácica

*sinal de Levine

-Duração

- 1 Angina estável- 2 a 3 minutos
- 2 Angina instável- 20 minutos
- 3 Infarto- horas

-Localização

-Irradiação

Qual a melhor conduta para um paciente com dor na emergência?

M: monitorar os sinais vitais, monitoração cardíaca, oximetria de pulso, PA, temperatura;

O: Oxigênio segundo a necessidade do paciente;

V: Veja: acesso venoso, coleta sanguínea e administração de medicamentos;

E: Eletrocardiograma





Causas de palpitação

Cardíacas

- arritmias
- ICC
- miocardites
- miocardiopatias

Não cardíacas

- HAS
- hipertireoidismos
- anemia
- esforço físico
- emoções
- síndrome do pânico
- tóxicas

-Fatores que pioram

- Atividade física
- Taquicardia
- Frio

-Fatores que melhoram

- Vasodilatador
- Repouso

Se o paciente referir dor torácica:

- Características da dor- apertada, pontada, sufoca
- Localização da dor- onde que tá doendo mais
- Intensidade da dor- (0-10)
- Irradiação da dor- se irradia pra costas, braços;
- Fatores de precipitação da dor- o que faz você sentir a dor, se sente parado ou fazendo algum esforço;
- Fatores de alívio da dor – quando deita, quando se levanta, quando senta;
- Duração da dor- quanto tempo que tá doendo, ou se vai e vem

Angina

É caracterizada por ataques paroxísticos causando dor precordial, de forma previsível e reproduzível em certo esforço, causado por isquemia do miocárdio transitória, podendo provocar necrose de miócitos

Características da dor isquêmica





Anamnese

- Dispneia, fadiga, náusea
- próximo ao esterno, no epigástrio até a mandíbula
- pressão, tensão ou peso
- duração de até 10 minutos

Diagnóstico

- É clínico na maioria dos casos
- Realiza eletrocardiograma
- pede marcadores cardíacos para eliminar IAM

Infarto agudo do miocárdio-IAM

Anamnese

- Pesquisar fatores clínicos relevantes, como por exemplo, histórico familiar, alimentação, dislipidemia, tabagismo, etilismo, prática de exercícios físicos
- características da dor, duração, local entre outras características, como se ele já sentiu antes

Exame físico

- Depende do quadro do paciente, importante realizar a estabilização do paciente através do MOVE, já na sala vermelha

Diagnóstico

- realizar o eletrocardiograma- supra de ST em pelo menos 3 derivações consecutivas
- Exames laboratoriais para avaliarem morte tecidual, como troponinas ultrasensível, T e I; CKMB e mioglobina

Hipertensão arterial sistêmica- HAS

Anamnese

investigar sintomatologia característica e sugestiva: dor de cabeça, fraqueza, visão embaçada, sangramento nasal, tonturas, zumbido no ouvido

Exame físico

Inspeção





Avaliar sinais de comprometimento cardíaco relacionado a evolução da doença

Palpação

- Palpar ictus cordis do paciente
- Avaliar se há presença de IC

Ausculta

- Auscultar presença de sopros cardíacos que possam estar levando a um aumento da pressão desse paciente

Exames

- Eletrocardiograma
- Raio x
- Exame de urina tipo I, potássio plasmático, glicemia, ureia, ácido úrico

Pericardite

Anamnese

- É importante avaliar se houve infecção viral ou bacteriana de 7 a 14 dias antes do início dos sintomas
- Febre baixa, taquicardia em repouso
- Dor de início súbito, piora com a tosse e a inspiração, piora com decúbito lateral esquerdo

Exame físico

Inspeção

- Dispneia
- Dor piora com a inspiração
- Melhora com a posição maometana
- Piora com a posição horizontal
- Turgência jugular, hepatomegalia, anasarca e ascite

Ausculta

- atrito pericárdico
- hipofonese nas bulhas (em caso de derrame pericárdico e tamponamento cardíaco)
- estertores pulmonares





Insuficiência venosa

Anamnese

- Número de gestações, cirurgias, traumatismo, permanência prolongada no leito, imobilização, anticoncepcionais, desidratação, antecedentes neoplásicos e prática de exercícios e a profissão do paciente

Sinais e sintomas

- dor, alterações tróficas (edema, celulite, hiperpigmentação, eczema, prurido, úlceras e dermatofibrose)

Exame físico

Inspeção

- Inspeção da perna como um todo, observando sinais do paciente, presença de edema, alteração de coloração, úlceras

Palpação

- temperatura (mais quente), umidade, sensibilidade, característica de edema (avaliar sinal do cacifo e classificar o edema), palpação dos pulsos

Ausculta

- detecção de sopros espontâneos

Exames

- Ultrassonografia com doppler das pernas
- D-dímero

Endocardite

Anamnese

- O quadro clínico para suspeita são pacientes com problemas congênitos no coração ou defeitos valvares adquiridos
- O quadro clínico é variável e é utilizado o critério de Duke para fins de diagnóstico clínico
- quadro de calafrio, febre, sinais de embolia séptica, petéquias,





Exame físico

Inspeção

- nódulos de Osler
- manchas de Roth
- manchas de Janeway

Palpação

- palpação dos nódulos de Osler

Ausculta

- Sopro cardíaco que pode ocorrer na valva atrioventricular esquerda e menos comum em direita

Doença arterial obstrutiva periférica – DAOP

Sinais e sintomas

- Os sinais e sintomas podem incluir: dor, alteração na cor da pele, temperatura mais fria, alterações tróficas (atrofia da pele, queda de pelos, úlceras arteriais) e edema
- *a claudicação intermitente é o sintoma mais comum- onde o paciente refere dor, aperto, cãibra, ao realizar exercício, mas que melhora ao repouso
- *a dor na claudicação intermitente está relacionada com o acúmulo de catabólicos ácidos e por produtos de degradação tecidual, como por exemplo a bradicinina, que atua diretamente nas terminações nervosas
- outra característica da dor é que ela se apresenta com grande intensidade quando o paciente se deita, uma vez que o fluxo sanguíneo em áreas mais distais diminui

*em alguns casos os sintomas podem ser menos intensos devido ao desenvolvimento da circulação colateral que vai surgir para compensar a artéria obstruída

Exame físico

Inspeção

- tipo de marcha, postura e fâcies; elevação ou abaixamento dos membros e observar a coloração, palidez, mancha, cianose e rubor

Palpação

- Temperatura da pele, elasticidade (dobrando a pele com os dedos); umidade da pele; tumoração
- Palpação dos pulsos periféricos, avaliando sua simetria e sua intensidade. Os principais pulsos são: carotídeos, radiais, cubitais, femorais, dorsais do pé e tibiais posteriores





Ausculta

- Buscar a presença de sopros
- É importante tomar cuidado para não comprimir a artéria causando um estreitamento artificial

Insuficiência cardíaca

Anamnese

- idade, profissão, hipertensão, histórico de infarto, dispneia aos esforços, ortopneia (em decúbito), pode ocorrer dispneia paroxística noturna (falta de ar no sono) e respiração de Cheyne-Stokes, fadiga, astenia

Exame físico

Inspeção

- distensão venosa jugular, através da inspeção estática e dinâmica, realizar a manobra de valsalva, pedir para o paciente mudar a angulação e avaliar a distensão jugular
- edema, ascite e hepatomegalia

Ausculta

- estertores pulmonares
- macicez, na base dos pulmões
- sopro sistólico de regurgitação mitral, inclinação de 25 graus
- terceira bulha (galope de B3)

Palpação

- Palpar o ictus cordis, que pode estar deslocado
- Verificar presença de edema, decorrente de icc direita
- Frêmito toraco-vocal, pode estar diminuído por conta do edema pulmonar
- Realizar o reflexo hepato-jugular para avaliar uma possível ic direita

Percussão

- macicez, na base dos pulmões

INSUFICIÊNCIA DIREITA	INSUFICIÊNCIA ESQUERDA
Edema periférico.	Edema pulmonar.
Turgência jugular.	Ictus cordis desviado para a esquerda.
Cianose.	Dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna.
Tosse.	Tosse noturna.
Respiração irregular.	Respiração de Cheyne-Stokes
Dificuldade de retorno venoso.	Dispneia de esforço.
Ortopneia.	Tiragem.
Inchaço maior à noite do que quando acorda.	Tontura.
Dispneia paroxística noturna.	Fraqueza.
Aumento do baço e do fígado. (esplenomegalia e hepatomegalia)	Dor muscular.
Sopros cardíacos.	Hipóxia
	Baqueteamento digital

Diagnóstico

- Exame de sangue- BNP, PNA





- eletrocardiograma
- ecocardiograma

Febre reumática

Anamnese

- mais comum em crianças
- Investigar infecção de garganta mal tratada de forma prévia
- analisar histórico familiar para a doença
- Leva a poliartrite migratória
- Nódulos de Aschoff no miocárdio, ocorre também a presença de vegetações nas cúspides valvares
- *critérios maiores: coreia de Sydenham, artrite, nódulo subcutâneo, eritema marginadum, cardite
- *critérios menores: febre, elevação de PCR, intervalo PR aumentado, artralgia

Exame físico

Inspeção

- Sinais de estase venosa pulmonar

Palpação

- Aumento global do coração

Ausculta

- sopros cardíacos, taquicardia, sopro, insuficiência mitral e aórtica bloqueio atrioventricular, atrito pericárdico e em alguns casos IC

Valvulopatia

Anamnese

- Arritmias cardíacas, cianose, crise hipoxêmica e síncope
- Dor torácica, dificuldade para se alimentar e/ou sudorese excessiva
- Intolerância aos exercícios, cefaleia e hipertensão
- Taquidispneia, edema e hepatomegalia, esplenomegalia

Exame físico

Inspeção

- palidez
- sudorese
- cianose





- baqueteamento digital
- pectus excavatum/ carinatum

Palpação

- hepatomegalia
- estase jugular
- abaulamento precordial

PATOLOGIA	PODE HAVER
ESTENOSE MITRAL	SOPRO DIASTÓLICO RESTRITO À PARTE PRÉ-SISTÓLICA DA DIÁSTOLE (telediástole) HIPERFONESE DE PRIMEIRA BULHA NO FOCO MITRAL ESTALIDO DE ABERTURA MITRAL HIPERFONESE DE SEGUNDA BULHA NO FOCO PULMONAR HIPERTENSÃO DO ÁTRIO ESQUERDO HIPERTENSÃO PULMONAR
INSUFICIÊNCIA MITRAL	ICTUS CORDIS DILATADO FRÊMITO SISTÓLICO NO FOCO MITRAL 3ª BULHA CARDÍACA SOPRO SISTÓLICO DE REGURGITAÇÃO NO FOCO MITRAL É POSSÍVEL TER UM SOPRO DIASTÓLICO CURTO
ESTENOSE AÓRTICA	PULSO PARVUS E TARDUS SOPRO HOLOSSISTÓLICO NO FOCO AÓRTICO FENÔMENOS DE GALLAVARDIN
INSUFICIÊNCIA AÓRTICA	PULSO EM MARTELO D'ÁGUA/CORRIGAN/MAGNO CÉLERE DESVIO DO ICTUS CORDIS SOPRO DIASTÓLICO E FRÊMITO DIASTÓLICO
ESTENOSE TRICÚSPIDE	SOPRO PROTO OU HOLODIÁSTÓLICO NO FOCO TRICÚSPIDE HIPERTENSÃO ATRIAL
INSUFICIÊNCIA TRICÚSPIDE	SOPRO HOLOSSISTÓLICO ALTO QUE AUMENTA COM A INSPIRAÇÃO PROFUNDA (RIVERO-CARVALLO) PULSAÇÃO HEPÁTICA SISTÓLICA HIPERTENSÃO PULMONAR

Sistema respiratório

Asma

Anamnese

Identificação do paciente

Fatores de risco

- histórico
- alérgenos
- infecção das vias aéreas superiores virais
- poluentes
- atividade física
- medicamentos: AAS, AINEs, beta-bloqueadores, IECA
- alimentos: corante tartrazina, leite de vaca





- mudanças climáticas
- fatores emocionais
- fatores hormonais: gravidez, menstruação
- Rinite alérgica

Sinais, sintomas e diagnóstico diferencial

- tosse, chiado no peito
- dificuldade respiratória
- os sintomas são frequentes e recorrentes
- piora a noite ou no início da manhã
- ocorre em resposta a desencadeantes
- frequência dos sintomas

Exame físico

Lembrar de realizar o exame físico cardiopulmonar

Inspeção

- Características do tórax
- Anormalidades
- Tipo de tórax
- Uso de musculatura acessória
- Tiragem

Palpação

- Frêmito toracovocal
- Expansibilidade

Percussão

- Percussão do tórax

Ausulta

- sibilos principalmente expiratórios
- taquipneia
- rinite associada
- dermatite atópica associada
- Sinais de gravidade: tiragem e uso de musculatura acessória, redução do nível de consciência, não há sibilos pois não tem ar

Exames complementares





- Espirometria
- Medidor de pico de fluxo expiratório (pfe) portátil
- Pode pedir raio x

DPOC

Anamnese

-Identificação do paciente

- Fatores de risco
- histórico prévio de tabagismo
- Tosse e suas características
- Se piora com a manhã
- alérgenos
- sinais, sintomas e diagnóstico diferencial
- tosse, chiado no peito
- dificuldade respiratória
- os sintomas são frequentes e recorrentes início da manhã, mas se perduram durante todo o dia
- frequência dos sintomas

Exame físico

*lembrar de realizar o exame físico cardiopulmonar

*realizar a aferição dos sinais vitais

Inspeção

- Características do tórax
- Anormalidades
- Tipo de tórax
- Uso de musculatura acessória
- Tiragem

Palpação

- Frêmito toracovocal
- Expansibilidade

Percussão

- Percussão do tórax





Ausculata

- Presença de roncos
- Taquipneia
- Sinais de gravidade: tiragem e uso de musculatura acessória, redução do nível de consciência, não há sibilos pois não tem ar
- Principais sinais de exacerbação é depois de infecção no trato aéreo

Exames complementares

- Espirometria
- Medidor de pico de fluxo expiratório (pfe) portátil
- Raio x

Tromboembolismo pulmonar – TEP

Anamnese

As principais manifestações clínicas na TEP não maciça são: taquipneia (> 20 ipm no adulto), dispneia, dor torácica pleurítica, taquicardia, apreensão, tosse e hemoptise,

*investigar sinais de TVP

Nos quadros maciços, colapso circulatório agudo e morte súbita podem ocorrer.

Exame físico

Inspeção

- Paciente dispneico
- Pode apresentar cianose
- Pode apresentar hemoptise
- Tosse
- Sinais de TVP
- Hemoptise
- Dor retrorbitária súbita

Diagnóstico

- Tomografia de tórax
- D-dímero
- Eletrocardiograma SIQ3T





Pneumotórax

Anamnese

- Reconhecer os sintomas característicos: dispneia intensa, dor torácica
- História clínica do paciente, histórico de doença prévia
- Avaliar a estabilidade do paciente
- avaliar a função pulmonar do paciente

Exame físico

Inspeção

- Tórax pode estar normal a inspeção, como também pode haver sinais de sofrimento respiratório
- dispneia característica
- pode haver uso de musculatura acessória

Palpação

- diminuição ou abolição do frêmito toracovocal
- expansibilidade diminuída

Percussão

- timpanismo
- sons aumentados

Ausculta

- Aumento dos sons pulmonares

Diagnóstico

- Raio X
- Tomografia
- Ultrassom

Derrame pleural

Anamnese

- Acúmulo anormal de líquido na cavidade pleural
- doença pleural primária





- pode ser resultado de: aumento intersticial pulmonar, aumento na pressão intravascular, aumento da permeabilidade capilar, diminuição da pressão oncótica
- pode ser também por diminuição da absorção
- sintomas: dor tosse, dispneia

Exame físico

Inspecção

- expansibilidade diminuída
- dor tosse, dispneia

Palpação

- Diminuição da expansibilidade
- Diminuição do frêmito toracovocal
- Diminuição Murmúrio vesicular
- Maciez à percussão

Percussão

- maciez ou submaciez, delimitação a presença de líquido

Ausculta

murmúrio reduzido, egofonia, atrito pleural, limite do derrame

Diagnóstico

- RX de tórax, PA e perfil *em decúbito lateral com raios horizontais
- Líquido pleural entre 100 a 150 ml
- linha de demosier
- tomografia
- ultrassonografia
- investigação é feita pela toracocentese

Classificação do derrame

Transudato

ICC, problema hepático, síndrome necrótica





Exsudato

Neoplasias, drogas, problemas digestivos, infecção

Pneumonia

Anamnese

- Identificação do paciente
- Avaliar sinais vitais
- saber o tempo
- saber se houve perda de peso

Sintomas

Dispneia; tosse seca ou produtiva; dor pleurítica; desconforto torácico; do abdominal; gerais: febre ou hipotermia, sudorese, fadiga, anorexia, mialgia

*no início de uma pneumonia bacteriana: no início não há expectoração ou é de forma discreta, depois de algumas horas ou dias ocorre uma secreção amarela-esverdeada pegajosa e densa. Na pneumonia causada por klebsiela, Pseudomona e Aerobacter a expectoração tem aspecto de geleia de chocolate

*no começo de uma pneumonia viral:

Exame físico

Inspeção

- Inspeção estática e dinâmica
- Tipo de tórax
- dispneia
- Uso de musculatura acessória

Palpação

- expansibilidade reduzida (ar não entra)
- FTV (frêmito toracovocal) aumentada

Percussão

- submacidez ou macidez
- Sinais de consolidação ou derrame pleural





Ausculta

- Roncos
- Som bronquial
- Abolição de sons
- Sinais de derrame pleural

Tipos

Broncopneumonia

No exame físico

- inspeção dinâmica: dispneia
- murmúrio vesicular diminuído
- crepitação, sibilo e ronco
- frêmito fisiológico ou aumentado
- som claro pulmonar ou submacicez

Pneumonia intersticial

- inspeção dinâmica: dispneia
- murmúrio vesicular fisiológico ou crepitação
- frêmito fisiológico
- som claro pulmonar

Pneumonia lobar

- inspeção dinâmica: dispneia
- afeta de maneira unilateral
- possui limites bem definidos no raio X

Pneumonia grave

- geral- cianose
- sinais vitais: temperatura menor que 35 ou maior que 40, pressão sistólica menor que 90

Tuberculose

Anamnese

- investigar a profissão do paciente
- investigar as condições de vida e moradia
- Indivíduo sintomático respiratório- Pessoa que, durante a estratégia programática de busca ativa, apresenta tosse por 3 semanas ou mais*. Essa pessoa deve ser investigada para tuberculose através de exames bacteriológicos
- avaliar se o paciente teve perda de peso progressiva





- contato com alguém com tuberculose
- fatores de risco
- sinais e sintomas: tosse seca, sudorese noturna, dor torácica e dispneia

Exame físico

Inspeção

- O paciente pode apresentar-se apático
- Dispneia
- Uso de musculatura acessória
- emagrecimento

Palpação

- Expansibilidade diminuída
- Frêmito normal na maioria dos casos

Percussão

- Hipertimpanismo por conta da cavitação

Ausculta

- Diminuição do murmúrio vesicular
- roncos
- estertores, majoritariamente em terço superiores pulmonares
- *realizar a notificação da doença

Exames

- Baciloscopia
- PPD (prova tuberculínica)
- raio X
- tomografia

Arboviroses

Anamnese

Sintomas relevantes: febre alta e de início súbito, cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, adinamia (falta de força física), exantema, anorexia (perdas de apetite), náusea, vômito, diarreia





Exame físico

- realizar exame físico cardiopulmonar
- *sinais de alarme- dor abdominal, ascite, derrames, hepatomegalia e sangramentos
- realizar prova do laço. Como é feito? realiza a aferição da pressão arterial, tira a média entre a sistólica e a diastólica. Sabendo disso insufla o manguito por 5 minutos em adultos e 3 minutos em crianças, a quantidade de petéquias vai até 20 em adultos e 10 em crianças, por 2,5 cm²

*OBS: realizar a notificação da doença mesmo na suspeita

Protocolo SPIKES

O protocolo (SPIKES) consiste em seis etapas e a intenção é habilitar o médico a preencher os 4 objetivos mais importantes durante a transmissão de más notícias:

- Recolher informações dos pacientes;
- Transmitir as informações médicas;
- Proporcionar suporte ao paciente;
- Induzir a sua colaboração no desenvolvimento de uma estratégia ou plano de tratamento para o futuro.
- Antes de ter o diagnóstico, abrir um leque de possibilidades sobre o diagnóstico. Evitar dar força para algum diagnóstico e ao mesmo tempo preparar para o pior dos diagnósticos.

Etapas

S (Setting up the interview)

Planejar/ensaiar a conversa mentalmente já que é uma situação de estresse.

Escolha um local que possibilite alguma privacidade; envolva pessoas importantes para o paciente, se for da sua escolha, como por exemplo os familiares; procure sentar-se (isso relaxa um pouco o paciente e demonstra que você não está com pressa) e mantenha contato com o paciente caso seja confortável para ele: contato visual, pegar no braço no paciente, como forma de acolhimento.

- LOCAL – privacidade
- CONTEÚDO – a par de todas as informações sobre o paciente
- PESSOAS IMPORTANTES PARA O PACIENTE
- RELAXAR – demonstrar que está disponível e sem pressa
- ACOLHIMENTO - demonstrar compaixão.
- TRATAMENTO, CONDUÇÃO DE TRATAMENTO, TIPOS. Caso o paciente corra risco de vida emocionalmente por conta da notícia, pode-se quebrar o sigilo médico e chamar alguém próximo ao paciente. Caso a adolescente seja emancipada, não precisa de acompanhante.

A Sociedade Brasileira de Pediatria, aceita o adolescente sozinho na consulta e o sigilo médico- paciente é mantido, até risco de vida. Porém, sempre tenta-se persuadir a adolescente a trazer um responsável.





P (Perception)

Avaliar a percepção do paciente.

Antes de falar sobre a doença, pergunte ao paciente o que já foi dito para ele sobre sua condição e quais as suas expectativas. Assim, você consegue entender o que se passa na cabeça do seu paciente, corrigir possíveis ideias incorretas e moldar a notícia para a compreensão do mesmo.

- PERCEPÇÃO SOBRE O ASSUNTO E EXPECTATIVAS DO PACIENTE – abertura para ouvir o que o paciente sabe
- CORRIGIR IDEIA INCORRETAS – diminuindo a ansiedade.
- DAR A NOTÍCIA DA MELHOR FORMA PARA COMPREENSÃO

I (Invitation)

Obtendo o convite do paciente.

Quando o paciente explicita a vontade de saber sobre tudo, o médico recebe o cartão verde para falar sobre a verdadeira condição do paciente. Entretanto, quando o paciente não deixa clara a sua vontade de saber toda a informação ou não quer saber, é válido que o médico questione ao paciente o que ele quer saber sobre a sua doença e sobre o resultado dos seus exames. Se o paciente não quer saber dos detalhes, se ofereça para responder a qualquer pergunta no futuro ou para falar com um parente ou amigo.

- CONVITE PARA EXPLICAÇÃO – respeitar o tempo do paciente.
- EXPLICAÇÃO - Explicar apenas o que o paciente necessita saber, caso ele não queira ouvir muitas informações
- LINGUAGEM - Independente da escolaridade, a notícia deve ser dada de forma clara e bem explicada

K (Knowledge)

Dando Conhecimento e Informação ao Paciente.

Avisar ao paciente que você tem más notícias pode diminuir o choque da transmissão dessas notícias e pode facilitar o processamento da informação. Informe ao paciente sua condição usando um vocabulário que facilite sua compreensão e demonstre compaixão. Passe as informações aos poucos e vá avaliando o grau de entendimento do paciente.

- AVISAR QUE TEM MÁS NOTÍCIAS – processamento de informações
- VOCABULÁRIO CLARO
- DEMONSTRAR COMPAIXÃO
- INFORMAÇÕES POUCO A POUCO – avaliar o grau do entendimento do paciente

E (Emotions)

Abordar as Emoções dos Pacientes com Respostas Afetivas





Demonstre compaixão e responda as emoções do paciente. Quando os pacientes ouvem más notícias a reação emocional mais frequente é uma expressão de choque, isolamento e dor. Nesta situação o médico pode oferecer apoio e solidariedade com uma resposta afetiva. Exemplo trazido pelo próprio protocolo SPIKES:

Perguntar sobre os sentimentos apenas se o paciente não expressar, ficar calado. Ou no final de tudo.

Preparar e explicar que muitas pessoas precisam de auxílio para passar por situações como essa e sugerir então um acompanhamento psicológico e oferecer o mesmo, explicando o porquê e deixando claro que não é para pessoas com transtornos mentais. Deixar claro os pontos positivos.

Dar a sugestão de conversas com pessoas que passaram pela mesma situação.

Exemplo: Médico: Sinto dizer que a radiografia mostra que a quimioterapia não parece estar fazendo efeito [pausa] Infelizmente, o tumor cresceu um pouco.

Paciente: Era o que eu temia! [Choro]

Médico: [chega sua cadeira mais perto, oferece ao paciente um lenço e pausa] Eu sei que isso não é o que você queria ouvir. Eu gostaria que as notícias fossem melhores.

Nesse diálogo o médico percebe a reação do paciente e se aproxima dele de maneira afetiva.

S (Strategy e Summary)

Estratégia e Resumo - sumarização.

Caso o paciente queira e esteja preparado, apresente as opções de tratamento e compartilhe a responsabilidade das tomadas de decisões. Para dar más notícias, devemos sempre entender o paciente, demonstrar compaixão e usar uma comunicação acessível.

Demonstrar compaixão não é dar falsas esperanças ao paciente! Caso ele queira, seja claro ao falar do prognóstico, mas tenha em mente que sempre temos algo para fazer por ele, mesmo que não seja a cura.

Em situações em que não há tratamento curativo, devemos oferecer conforto ao paciente e deixar isso claro para ele. O cuidado de fim de vida é uma situação de estresse para o médico, mas deve ser dada a mesma importância que o tratamento curativo de uma doença.

RESUMO – saber o que o paciente entendeu sobre o que foi explicado. Fazer uma síntese geral com os pontos principais e procurar saber se o paciente captou os pontos positivos também.

PERGUNTAR – pedir para o paciente explicar o que foi entendido e reafirmar todas as explicações e soluções.

→ Perguntar se está tudo bem, para saber se o paciente pode ser liberado.

→ Caso não possa liberar o paciente, explicar que não pode ser liberado e pedir o contato de alguém de confiança e posteriormente explicar sobre tratamento mental.





Protocolo SPIKES júnior

As crianças são muito resilientes e possuem uma força extraordinária quando se trata de situações difíceis, e por conta da imaginação, inocência e capacidade de acreditar no futuro conseguem passar pelos problemas de forma mais leve que os adultos.

Apesar de serem crianças, não se pode menosprezar a capacidade de entendimento delas em relação a situações complicadas. Precisam de apoio diante de situações difíceis, porém é necessário que não haja impedimento da vivência da experiência pelo fato de serem crianças, pois tal aprendizado irá gerar amadurecimento e desenvolvimento sentimental para circunstâncias posteriores, até mesmo quando adultas, facilitando o processo de absorver e saber lidar com as dificuldades.

Como as crianças entendem a morte?

♥ Compreendendo o conceito de morte: As 4 características da morte vão sendo incorporadas de acordo com a etapa de desenvolvimento do pensamento.

* Irreversibilidade: compreensão de que o corpo físico não pode viver depois da morte.

* Não funcionalidade: compreensão de que todas as funções definidoras da vida cessam com a morte.

* Universalidade: compreensão de que tudo que é vivo, morre.

* Casualidade: compreensão do porquê a morte ocorreu. Os adultos possuem as quatro características incorporadas.

Nas crianças, nem sempre essas características seguem a ordem e estão estruturadas corretamente.

Etapas de desenvolvimento infantil

Piaget: Teoria Cognitivo-Desenvolvimental

♥ Capacidade de adaptação. Fases do desenvolvimento: Período pré-operacional ou pré-escolar: até 5 anos.

♥ Até 5 anos: a criança não reconhece a irreversibilidade, a não-funcionalidade e a universalidade.

♥ Mundo mágico: misturam fantasia com realidade.

♥ Animismo: as crianças dão vida a seres inanimados. Conversam com carrinho, pelúcias, amigos imaginários.

Período operacional: 5 aos 11 anos.

♥ Operacional concreto: dos 5 aos 9 anos. A criança já distingue a irreversibilidade, a não funcionalidade, mas não a universalidade, ou seja, a inevitabilidade da morte.

* A morte é algo bem distante para eles.

* Reproduzem rituais com os animais que morrem: Importante começar a fazer o entendimento dos rituais, aproveitando situações como morte dos animais de estimação.





- * Possui um pensamento lógico.

♥ Operacional formal: até os 11 anos.

A morte vai tornando-se um fato natural, mas falta ainda a abstração:

- * Como quais as consequências da morte para a criança e para as outras pessoas?
- * O que há depois da morte?

♥ Adolescência: Desenvolvimento do pensamento abstrato:

- * Possibilidade de compreensão da morte
- * Início da percepção como adulto em relação a morte

* Começa a estruturação das características da morte: irreversibilidade, não-funcionalidade, universalidade e casualidade.

Spikes Júnior

O Protocolo Spikes Júnior aborda nuances de como passar uma notícia difícil para uma criança. Os passos são os mesmos do Protocolo Spikes:

S: setting up — preparo.

P: perception — percepção do paciente sobre o diagnóstico.

I: invitation — convite.

K: knowledge — transmissão da notícia.

E: emotion — trabalhar as emoções do paciente.

S: summary and strategies — sumarização e estratégias.

As emoções das crianças são mais afloradas, mas nem sempre elas exteriorizam, cabendo a nós, a percepção dos sentimentos através das brincadeiras, desenhos, massinha de modelar, pinturas, bonecos.

Quando são notícias mais intensas envolvendo morte ou separação é importante que tenha um profissional da pediatria que trabalhe com comportamento infantil ou associado na equipe um profissional da área de saúde mental especializado em crianças ou que este profissional esteja na equipe que irá dar a notícia, para que seja analisado o comportamento. É importante sempre analisar o entendimento das crianças em relação a notícia, pois muitas vezes elas demonstram que entenderam e posteriormente é observado que o entendimento que a criança tem não é condizente com o de um adulto e nem com o que realmente aconteceu.

Sempre voltar para a percepção da criança em relação a notícia. Inúmeras vezes.





CONSIDERAÇÕES

O **Spikes Júnior** é direcionado a criança, dessa forma a criança que irá receber a notícia. Há equívoco, pois muitas vezes quem recebe a notícia são os pais ou responsáveis. É importante salientar que o **SPIKES** que é aplicado com os pais ou responsáveis faz parte do **Spikes Júnior**, e é uma preparação inicial das pessoas que irão apoiar a criança e ajudar na transmissão da notícia para a criança. Os receptores da notícia difícil são crianças ou adolescente.

♥ Não poupar os pais ou responsáveis, pois eles precisam saber tudo para poderem tomar decisões em conjunto com o profissional.

♥ O protocolo com os pais pode ser aplicado mais de uma vez, até o momento em que eles estejam preparados e emocionalmente estáveis para dar suporte a criança.

♥ Nunca se deve mentir para uma criança. Deve-se procurar modos para que eles extravasem as emoções com uma pessoa de confiança e tentar justificar de forma positiva, procurando mostrar um lado bom, diante de situações ruins como a aplicação de uma vacina. Não podemos perder a confiança da criança.

♥ Necessário trabalhar a criança diante de grande probabilidade de situações difíceis que estão por vir.

Ex: grande probabilidade de amputação.

♥ Importante: dependendo da notícia, não se conta tudo para criança, a não ser que ela pergunte. Ex: prognóstico de câncer. Com os responsáveis é necessário explicar tudo, por conta das decisões que precisam ser tomadas juntamente com a equipe.

♥ A criança não é obrigada a saber um prognóstico de morte, por exemplo. Mas à medida que ela possui um entendimento maior e percebe o prognóstico, é importante que converse com a criança mesmo os pais sendo contra. A conversa é necessária para buscar acalmar e apaziguar os pensamentos e sentimentos da criança. Esclarecer e tranquilizar.

♥ Caso os pais se recusem a conversar com a criança e os dois estejam em fases sentimentais diferentes, é necessário trabalhar ambas as partes isoladas. E simultaneamente, tranquilizar a criança de que os pais estão tristes, mas quando estiverem preparados irão conversar sobre o assunto com ela. Obter informações no Spikes com os responsáveis para aplicar no júnior. Desenhos que gostam.

Etapas

S (Setting up the interview)

Planejar/ensaiar a conversa mentalmente já que é uma situação de estresse.

Preparo.

♥ Local: que traga tranquilidade para criança. Ambientes infantis com cores menos agressivas que transmitam paz e harmonia. Muitas vezes não é possível ter um local bem-preparado, então é importante que seja o mais tranquilo e acolhedor dentro da medida do possível, com menos intercorrências.

♥ Conteúdo: como explicar o que vai ser dito de acordo com o desenvolvimento do pensamento da criança.

* Verificar o prontuário, as ocorrências com o parente. O que foi trabalhado até então e até onde vai o conhecimento da criança em relação aos acontecimentos.





* Procurar algumas similaridades e metáforas para que entendam, na linguagem deles o que está acontecendo: histórias, filmes, desenhos podem ser usados

→ Crianças de 2 a 5 anos, de acordo com a teoria desenvolvimentista cognitiva, estão no estágio pré-operacional. Nesse estágio, de acordo com Piaget, o pensamento da criança é mágico e baseado em percepção.

Ex1: uma criança jamais trocaria uma bolsa com vinte moedas por uma nota de cem reais. Na percepção dela, não é justo trocar vinte coisas por uma.

Ex2: pedir a uma criança para comparar duas jarras que cabem o mesmo volume, sendo uma mais baixa e larga e a outra mais alta e fina, a criança irá olhar a jarra que está no nível mais alto e apontar aquela como a que cabe mais volume. Tudo isso é devido ao pensamento por percepção.

♥ Pessoas: receber a família

* Interessante aplicar o SPIKES com as pessoas que darão suporte emocional à criança

* O protocolo deve ser aplicado quantas vezes necessário, até os responsáveis estarem preparados e emocionalmente estáveis para dar suporte à criança. * Preparo emocional da equipe e verificar com quem o paciente criou vínculo.

* É interessante que o paciente receba a notícia da pessoa da equipe com quem criou vínculo.

* Muitas vezes a criança pode criar um vínculo com dualidade: ter confiança e medo ao mesmo tempo. Nesse momento é importante ter cuidado e entender o sentimento da criança e trabalhar alternativas para tentar diminuir o vínculo negativo.

P (Perception)

Avaliar a percepção do paciente.

Perceber o que o paciente sabe sobre o seu diagnóstico.

* Se sabe por que está hospitalizado.

* Se sabe por que está "dodô".

* Se sabe o que aconteceu.

* Se sabe onde ele está, e o que significa estar nesse local (hospital) para a criança.

♥ Eleger recursos lúdicos para melhorar a compreensão da criança de acordo com sua idade (mundo mágico).

I (Invitation)

Obtendo o convite do paciente.

Convite

♥ Saber dosar o que dizer para a criança





♥ Para os pais no SPIKES aplicado anteriormente a eles, responder tudo o que eles perguntarem, geralmente com mais detalhes.

♥ Oferecer-se para responder as perguntas da criança

♥ Introduzir a notícia

* Depende da idade da criança como será essa introdução.

♥ Utilizar expressões como:

* "Tenho uma coisa chata a te dizer.."

* "Nós estamos com um problema para resolver.."

* "Você sabe por que está doente?"

K (Knowledge)

Dando Conhecimento e Informação ao Paciente.

Transmissão da notícia

♥ Quem irá dar a notícia para a criança? Preparar quem dará a notícia no SPIKES anterior.

* Família dará a notícia: preparar a família no SPIKES anterior. Caso precise, mais de uma conversa até que a família esteja estruturada e consiga dar a notícia para a criança

* Profissional de saúde na presença da família: muitas vezes a família pede que o profissional dê a notícia. A notícia será dada na presença da família

* Profissional de saúde, a pedido da família: dará a notícia. Às vezes os pais não conseguem estar presentes, nesse caso sempre pedimos alguém próximo a criança que esteja presente no momento, para apoiá-la e dar suporte → Profissional de saúde sozinho com a criança: exceções e casos bem específicos. Necessário buscar alguém do convívio da criança, alguém com quem ela tenha um vínculo maior que a equipe

♥ Introduzir a notícia

* Evitar termos técnicos, dúbios

* Utilizar técnicas lúdicas

* Evitar falar pormenores sobre os quais o paciente ainda não perguntou

* À medida que se vai dando a notícia, vai sondando o que a criança está compreendendo e quais as dúvidas

* O entendimento sobre prognóstico e, principalmente sobre a morte é diferente no desenvolvimento do pensamento

E (Emotions)

Abordar as Emoções dos Pacientes com Respostas Afetivas

Trabalhar as emoções do paciente





♥ Expressão das emoções:

- * Negação.
 - * Raiva
 - * Barganha
 - * Depressão.
 - * Aceitação
 - * Mudez: por não entendimento; não prestou atenção no que foi passado; fuga da notícia
 - * Observar a comunicação não verbal: olhar, gestos, desenhos, brincadeiras enquanto ouve
 - * Medo de esboçar suas emoções:
- → Permitir que chore, fique triste ou com raiva sem preocupar em esconder suas emoções em esforçar-se para “proteger” seus pais da dor.
 - → Respeitar o tempo de reflexão da criança
 - → Ajudar a criança a entender a emoção dos pais: explicar o que está acontecendo, explicar.

S (Strategy e Summary)

Estratégia e Resumo - sumarização.

♥ Resumir o que foi dito: verificar o que ficou retido, o que precisa ser corrigido e o que precisa ser reafirmado.

- * “O que a tia falou?”
- * “Por que você tá dodói?”
- * “Por que tá internado?”
- * “Por que precisa fazer essa cirurgia?” Enquanto pergunta, a criança vai respondendo o que entendeu e é necessário ir corrigindo o que estiver errado e reafirmando no que precisar.
- * Discutir estratégias: de tratamento curativo ou paliativo. Dividir responsabilidade de decisões com os pais

* Desejos da criança: no nível de entendimento deles, com o auxílio de estratégias usando de artifícios que a criança goste. Tudo para melhorar a experiência da criança

- * Nunca mentir para a criança
- * Não mentir, nem subestimar a capacidade de crianças e adolescentes: não são coitados, nem bobos.
- * As crianças e adolescentes desenvolvem um amadurecimento muito grande diante de situações difíceis
- * Propor e mostrar várias opções substitutivas do que a criança não pode mais fazer. Tentando fazer com que ela enxergue o lado bom.

Estratégias para usar como auxílio no momento da aplicação do SPIKES na criança

Livros para leitura:

♥ O pequeno médico/ E agora? — Criança lidando com o luto por suicídio.

Filmes:

O Rei Leão. / Festa no céu

